

10 - 01-Révision anatomie (Teams) - Pr. KRIET

Vous voyez ici, sur l'intérieur de la paroi supérieure de l'orbite, à gauche, la force qu'on appelle la périoste qui recouvre l'orbite, c'est la périoste orbitaire, l'os frontal, et c'est la grande aile du sphénoïde, la force temporale, et c'est le solide hythmoidal en arrière et la gouttière olfactive derrière. Voilà la paroi supérieure de l'orbite de droite. La force électroclaire, ici, c'est en-dedans, en avant et en-dedans, et ici, la force lacrymale, deux repères anatomiques très importants de la paroi supérieure de l'orbite.

La force électroclaire, où il y a une réflexion de la poulie du muscle oblique supérieur, et la force lacrymale, ici, en avant et en-dehors, où se loge la glande lacrymale principale. Ici, l'os frontal, ici, la petite aile du sphénoïde, et ici, la fissure orbitaire supérieure, où il y a un passage des éléments vasculaires qui innèvent l'orbite osseuse. Et ici, le suture frontal sunoidale, et ici, la portion frontale du muscle oblique de l'os frontal.

La paroi orbitaire extérieure, qui a également une forme triangulaire, donc à base antérieure, cette paroi est formée par trois os, en arrière et en avant, la grande aile du sphénoïde, en avant et en bas, l'os malaire et l'os frontal. Ces trois os se réunissent pour former les deux sutures, la suture frontal malaire et la suture sphénoïde suno-malaire. Elles constituent la plus solide et la plus épaisse des parois de l'orbite.

En arrière, un peu en dessous de la suture frontal malaire, on trouve la tubercule du huitaine qui donne assertion sur le gammeau partébral interne, qui est très important sur le plan physiologique pour la fermeture du copier. Cette paroi est contrainte de rapport avec la force temporale en avant et l'étage moyen de la base de crâne en arrière. Vous voyez ici la paroi externe de l'orbite.

Ici, c'est l'os zygomatique, trois os, la forme triangulaire à base antérieure et à somme postérieure triangulaire, à base antérieure et à somme postérieure. L'os zygomatique, ici, la grande aile du sphénoïde en arrière et en haut, c'est la suture orbitaire de l'os frontal. L'os frontal, les os zygomatiques en bas et en avant et la grande aile du sphénoïde en arrière.

Le plancher orbitaire haut à la paroi inférieure, il a également une forme triangulaire. La paroi inférieure, c'est une paroi très fragile. Il a une épaisseur de 0,5 mm qui sépare le contenu orbitaire de ce mixte maxillaire inférieur.

Elle est constituée par trois os, l'os zygomatique en avant et en dehors, l'os maxillaire en avant et en dedans, le processus orbitaire du palataire en arrière, cette paroi et le siège du sillon orbitaire qui s'étend en arrière et en avant pour converser le canal devant sa partie antérieure. Et le contrat de rapport avec le mixte maxillaire en bas, vous voyez ici la paroi inférieure, elle est constituée de la forme triangulaire, à base antérieure et à somme postérieure. Elle est constituée par trois os, l'os zygomatique en avant et en dehors, en avant et en dehors, le maxillaire ou la

branche montante au maxillaire ou le processus orbitaire de l'os maxillaire en avant et en dedans et l'os palataire en arrière.

Voilà ici la fiche orbitaire inférieure et le canal, le sillon infrarorbitaire qui s'ouvre ici en avant au niveau de l'orbitaire inférieur par le canal infrarorbitaire qui est l'espacement en air infrarorbitaire et l'artère infrarorbitaire. La paroi intérieure a une forme quadrilatérale, ce n'est pas une forme triangulaire comme les autres parois, elle a une forme quadrilatérale. Cette paroi est formée d'arrière en avant par une partie de la face latérale du corps de swing 8, la lampe est assise sur l'os plan de l'orbite, l'os lacrymal et le processus orbitaire de l'os maxillaire.

Vous voyez ici la paroi médienne de l'orbite, elle est formée en arrière d'abord en avant la branche maxillaire, la branche montante au maxillaire de l'os maxillaire, l'os lacrymal, l'os plutoorbitaire et en arrière l'os finorbitaire. La surface orbitaire de l'imbus est divisée en deux parties par une crête verticale ou arête verticale qu'on appelle la crête lacrymale postérieure, en avant de la crête lacrymale postérieure on trouve la gousière lacrymale, on va soulever le sac lacrymal puis en avant la crête lacrymale antérieure que d'une insertion au tendon direct de ligament par des voiles internes. Cette paroi contient des rapports avec le sinus éthy-midal et l'éthy-midal en dedans.

Voilà les rapports le sinus éthy-midal en arrière et l'éthy-midal en arrière, les trous éthy-midal antérieur et postérieur qui disent passage pour les artères éthy-midales antérieures et pour l'artère éthy-midale postérieure. Ici on appelle la crête lacrymale, la crête lacrymale ou arête lacrymale, la crête lacrymale postérieure qui sépare donc la crête lacrymale antérieure et la crête lacrymale postérieure qui forment une gouttière lacrymale, on soulève la glande, on soulève le sac lacrymal, on appelle la gouttière lacrymale. Ici se trouve, soulève le sac lacrymal.

Voilà un autre schéma, notre schéma donc l'os thymidal en arrière, l'os éthy-midal, et l'os lacrymal et la branche maintenant de maxilla inférieure. Alors pour la base de l'orbite, elle est circonscrite par le robot orbitaire. C'est la base de l'orbite qui est circonscrite par le robot orbitaire.

Le robot orbitaire supérieur est constitué par l'os frontal. Le robot orbitaire externe ici, il est formé par deux os. En haut c'est la prophète orbitaire externe de l'os frontal, c'est l'os frontal ici.

Et en bas, c'est l'os malaire. Le robot orbitaire inférieur, il est formé en dehors par le malaire et en dedans par la prophète pyramidale ou la prophète montante de maxilla supérieure. Il n'y a pas de robot orbitaire interne.

Il y a trois robots supérieurs, latéraux et inférieurs. C'est bien ? C'est bon ? Vous m'entendez ? Pour le sommet orbitaire ou l'apex orbitaire, c'est la convergence de l'orbite avec les parois orbitaires en arrière, qu'on appelle l'apex orbitaire ou le sommet orbitaire. Elle répond à l'extrémité interne de la fissure orbitaire supérieure.

Un peu au-dessus, lui, se trouve l'orifice du canal lacrymal qui livre un passage au lac lacrymal et

au nœud optique. Et puis, il est fermé par la face orbitaire rectangulaire. Deux orifices s'ouvrent dans la cavité crânienne.

Le trou supérieur interne et un autre intérieur qu'on verra par la suite. Les orifices de l'orbite. D'abord, le canal optique.

C'est un orifice ovulaire qui est creusé dans la base de l'apex. Dans l'apex orbitaire, le trou optique représente l'orifice antérieur du canal optique. Il y a le canal optique qui est creusé dans l'océan orbital et le trou optique représente l'orifice antérieur du canal optique.

Il fait communiquer l'étage antérieur de la base de crâne avec l'orbite. Il livre passage au nœud optique et à la terre optique. Deux éléments anatomiques très importants à reconnaître.

C'est le nœud optique et la roue ptalmique qui passent par le canal optique. Entre le trou optique et la partie large de la fonce humidale, il existe la tubercule sous optique qui donne assertion au tendeux de Zin. On ne verra pas la suite.

C'est l'origine des muscles opulomoteurs. Vous voyez ici le trou optique et la fissure orbitaire supérieure qui fait communiquer entre la cavité orbitaire avec la fonce cérébrale antérieure. C'est la fissure orbitaire supérieure.

Il y a une fissure orbitaire inférieure, on verra par la suite. Le trou optique, c'est le trou optique qui est sur l'orifice antérieur du canal optique qui livre passage aux artères optalmiques et au nœud optique. La fissure orbitaire supérieure a une forme de massue, donc à grosses extrémités inférieures et internes.

La fissure orbitaire supérieure au fond de la fonce humidale est destinée entre la petite et la grande pelle de Spineweed. La partie ronflée inférieure interne divisée par l'anneau de Zin est traversée à l'intérieur de l'anneau de Zin, donc le nerf nasal, le nerf moteur oculaire commun, c'est la branche supérieure du nœud 3, et le nerf 6, c'est le nerf moteur oculaire externe. Au dehors de l'anneau de Zin, c'est le nerf pathétique, le nerf trochléaire, le nerf 4, le nerf frontal, le nerf lacrymal, et la veine optalmique supérieure.

Vous voyez ici, c'est la fissure orbitaire. Il a une masse infilée, comme une virgule, qui est divisée par l'anneau de Zin en deux parties. La partie externe de l'anneau de Zin, voilà l'anneau de Zin.

La partie externe au dehors de l'anneau de Zin. Ici, livre passage, le nerf trochléaire, le nerf 4, le nerf frontal, le nerf lacrymal, et la veine optalmique supérieure. Parfois, on pose la question, quels sont les éléments qui traversent la fissure orbitaire en dehors de l'anneau de Zin, ou bien en dedans de l'anneau de Zin.

Il faut faire attention. Les éléments qui traversent la fissure orbitaire, soit en dedans, soit en dehors de l'anneau de Zin. Par contre, les éléments qui traversent la fissure orbitaire en dedans de l'anneau de Zin, c'est le bronze supérieur, la bronze inférieure de nerfs mentaux oculaires

communs, c'est-à-dire le nerf 3, et le nerf nasophilaire, le nerf 6. C'est ça, les éléments qui traversent la fissure orbitaire à l'intérieur, ou bien en dedans de l'anneau de Zin.

La fissure orbitaire inférieure, elle n'a pas une particularité anatomique comme la fissure orbitaire supérieure. Elle fait communiquer l'orbite avec la force ptérogrope palatine. Les trous éthymidaux antérieurs et postérieurs, dont la paroi médiane de l'orbite, qui livre passage aux artères, au nerf éthymidaux, le nerf antérieur et le nerf postérieur.

Vous voyez ici les orifices éthymidaux, postérieurs et antérieurs, donc les trous éthymidaux, ou les orifices éthymidaux antérieurs et postérieurs, qui livre passage aux artères éthymidales, éthymidales antérieures, et les artères éthymidales postérieures. Vous voyez ici, les éléments, les orifices de l'orbite, le canal optique, la fissure orbitaire supérieure, c'est un repère anatomique très important à reconnaître, et la fissure orbitaire inférieure, et les trous éthymidaux antérieurs et postérieurs. Alors, voilà ici, quelques applications cliniques, ou bien des éléments cliniques, qui intéressent l'orbite, surtout des fractures.

Ici, c'est une fracture de la paroi inférieure, ou paroi de plancher. Ici, une fracture de la plancher de l'orbite gauche, avec une incarceration, ici, une carcération comme une goutte, une carcération du muscle oblique, le muscle oblique inférieur, et le muscle droit inférieur, ici, et la graisse orbitaire, parfois, des éléments anatomiques cliniques, par choc. Ici, voilà une fracture, avec un effondrement, carrément de la paroi inférieure de l'orbite, c'est le plancher de l'orbite gauche, ici.

Là, c'est un processus intra-orbitaire de l'orbite gauche, un hyggeophthalmie, c'est-à-dire, par l'existence, par la présence d'un processus intra-orbitaire, comme ça, qui permet de refouler, de repousser le globocule en avant. Il s'agit d'un conflit entre le contenant, c'est-à-dire l'orbite, et le contenu, c'est-à-dire le globoculaire. Lorsqu'il y a une masse ou un processus n'importe qui l'érigine, soit une masse, soit un hématome, donc il n'y a pas d'espace qui permet de contenir, ce qui permet de refouler le globoculaire en avant, et qui est responsable de l'hyggeophthalmie, c'est-à-dire de protéger le globoculaire en dehors de la cavité orbitale.

Pour la vascularisation de l'orbite rapidement, pour la vascularisation d'orbite, la vascularisation de l'orbite est assurée par deux systèmes artériels, le système carotidien interne par l'artère optalmique, et également par le système carotidien externe par l'artère intra-orbitaire. Il faut retenir que l'orbite est vascularisée par deux systèmes, mais surtout le système carotidien interne par l'artère optalmique. L'artère optalmique prend en charge la quasi-totalité de l'apport artériel.

Le retour est assuré par les veines optalmiques, les veines optalmiques supérieures et inférieures. Vous voyez ici, c'est l'artère carotidien interne qui donne l'artère optalmique. C'est la branche collatérale de l'artère carotidien interne qui passe par le canal optique et qui sort par le trou optique au-dessous du neurotique.

Ce qui jante, c'est le neurotique au-dessous du neurotique. Il est d'abord au-dessous du neurotique et il devient plutôt latéraux au-dessous du neurotique pour loger la paroi médiane de l'orbite. Voilà, c'est l'artère optalimique qui donne plusieurs branches collatérales à destiner annexia, c'est-à-dire pour les annexes de l'orbite.

On verra par la suite. C'est presque la quasi-totalité de la vascularisation de l'orbite assurée par l'artère optalimique. L'artère optalimique, ils ont la cavité crânienne, l'artère qui pénètre dans l'orbite par le canal optique et ils donnent de nombreuses branches collatérales destinées aux globoculaires et aux annexes.

C'est une branche collatérale de l'artère carotidantaire et qui présente trois segments. Un segment intracrânien après son origine et un segment intracrânien dans le canal optique. C'est un segment intraorbitaire.

Il prend l'origine au niveau de la face de la carotidantaire, on la situe au-dessus de la frette exclusivitaire empériale. Trois segments, un segment intracrânien qui est des longueurs très variables, 3 à 15 mm, l'artère naissant directement de la carotidantaire et un segment intracrânien à ce niveau l'artère insuline au-dessus de l'orbite optique. Puis un segment intraorbitaire qui comporte trois parties, l'artère optique c'est-à-dire en dehors de l'orbite optique supra-optique, c'est-à-dire au-dessus de l'orbite supra-optique, et l'artère midi-optique, c'est-à-dire en-dedans par rapport au trajet de l'orbite optique.

Il se termine au niveau flanc supra-interne d'orbite après avoir perforé le septum orbitaire et se termine par l'artère angulaire au niveau flanc supra-interne. Donc c'est la branche terminale c'est la seule branche terminale de l'artère optique au niveau de flanc supra-interne. Ici vous voyez l'artère angulaire donc l'artère optique qui donne la branche terminale angulaire au niveau flanc supra-interne après avoir perforé le septum orbitaire.

Alors la branche collatérale donc les branches collatérales de l'artère optique c'est très nombreuse, donc elles sont très variables en origine, en nombre de grands groupes, donc les artères destinées à l'optique, c'est-à-dire l'artère centrale de l'arythme les artères ciliaires, donc l'artère centrale de l'arythme, c'est ce qui permet la vascularisation de l'arythme. Et les artères ciliaires longues et courtes. Et les artères de l'optique, donc il y a trois types d'artères pour les artères destinées à l'optique.

L'artère centrale de l'arythme c'est parfois pour la vascularisation de l'arythme les artères ciliaires longues c'est-à-dire qui traversent la supracorroïde arrivent jusqu'à le segment ontarien du globoculaire et qui participent à la vascularisation de l'uris qu'on appelle par le grand cercle artérien et les artères courtes qui traversent la corroïde autour de la papille optique et qui constitue le support vasculaire de la corroïde qu'on appelle la coriocapilla et les artères de neuroptique, c'est-à-dire que le neuroptique il est vascularisé également par des artères de l'artère ophtalmique. Les branches à destinée anexiales, ce sont des branches qui sont destinées

aux muscles les muscles oculomoteurs la graisse orbitaire pour les glandes les glandes lacrymales principales et accessoires et par les voies lacrymales de drainage. Donc toutes ces branches à destinée anaxiales sont divisées en plusieurs branches qu'on appelle les branches supraorbitaires, l'artère lacrymale les artères musculaires et les artères papillomaires.

L'artère centrale de la rétine c'est une artère qui est constante l'artère centrale c'est une artère constante qui prend naissance au niveau de directement de l'artère ophtalmique dans 50% de cas et qui chemine le long de la face inférieure de la neuroptique, qui pénètre à l'intérieur de la neuroptique, puis se termine à la papille par cette branche terminale. Vous voyez ici c'est l'artère centrale de la rétine, qui prend naissance au niveau de l'artère ophtalmique dans 50% de cas, qui pénètre au niveau à l'intérieur, qui chemine à l'intérieur de la neuroptique, et qui souffre, qui se termine au niveau de la papille optique ici. Lorsqu'on fait un examen au 2 fonds 1, on voit ici c'est l'émergence de l'artère centrale de la rétine qui donne des branches collatérales, des branches temporales supérieures des branches temporales inférieures, des branches nasales supérieures et des branches nasales inférieures qui séparent en façon dichotomique, qui permet la vascularisation de la rétine.

Les artères de neuroptique qui sont nombreuses, donc celles qui sont issues du segment intracanalien d'artères ophtalmiques, et celles qui sont issues du segment intraorbital. Donc les artères ciliaires courtes postérieures, deux groupes, donc l'angle qui participe au grand CAPL de l'IRIS, et les artères ciliaires courtes, très nombreuses, qui décident la vascularisation de la corne. Donc il faut séparer les deux.

Les artères ciliaires longues participent à la vascularisation des artères du segment antérieur, c'est-à-dire la grande artère de l'IRIS. Et les artères ciliaires courtes, il y en a très nombreuses, sont destinées à la vascularisation de la corne. Si vous voyez ici, c'est les artères ciliaires courtes, qui pénètrent au niveau de la sclère autour de l'axe optique et qui permettent la vascularisation de la corne.

Et la grande cècle artérielle ici, les artères ciliaires longues, qui participent à la vascularisation de la grande cècle artérielle de l'IRIS. Les artères lacrymales, les artères lacrymales destinées à l'angle lacrymal, donc c'est une branche collatérale de l'artère ophtalmique. Les artères supraorbitaires, qui naissent à la face supérieure de la portion milieu-optique de l'artère ophtalmique et qui se terminent au niveau du muscle, au niveau de la pupille supérieure et de l'oblique supérieur.

Puis les artères éthmoïdaux. Il y a deux types d'artères éthmoïdaux. Il y a deux sortes d'artères éthmoïdaux, postérieure et antérieure.

Pour les artères postérieures, qui se terminent au niveau et qui permettent plutôt de les faire disparaître. Pour les artères éthmoïdaux, il y a un type d'artère qui est un type d'artère qui permet de faire disparaître les artères dans l'entraînement. Donc, il y a un type d'artère qui est un type

d'artère supérieures.

Par exemple, Les artères papébrales supérieurs marginaux et les artères papébrales supérieures périphériques. Les artères papébrales supérieures marginaux et les artères papébrales supérieures périphériques. Pour les branches terminantes, c'est l'artère papébrale supérieure marginale et l'artère papébrale supérieure périphérique.

Le système carotidien, après avoir vu le système carotidien, le système carotidien externe, c'est par l'intermédiaire de l'artère infrarotitaire, qui prône l'origine au niveau de l'artère maxillary, qui se termine dans la région de canal lacrymonasale. Et pour les artères ménagères lacrymales, qui sont pénétrées dans la cavité orbitaire par la paroi latérale. La vascularisation veineuse, le retour veineux est calqué, le retour de contenu orbitaire n'est assuré par trois veines, les veines ophtalmiques supérieures et inférieures et les veines ophtalmiques moyennes.

Pour conclure, on peut dire que l'évaluation d'une atteinte orbitale doit distinguer les lésions, soit intra-orbitale, soit pyro-orbitale, soit intra-oculaire. Intra-oculaire c'est à l'intérieur de l'orbite, intra-orbitale c'est à l'intérieur de l'orbite. Il y a un conflit entre le contenu, le contenu avec comme conséquence les ophtalmiques, et le pyro-orbitale, c'est-à-dire en dehors de l'orbite.

On peut céder par la clinique, pour savoir l'interlocutoire, pour rechercher une douleur au niveau de l'orbitaire, de douleur oculaire, de douleur orbitaire. L'armement rhénoré, il pousse mieux s'il y a un problème rhénologique. L'inspection, pour savoir, pour rechercher une paralysie globoculaire, une exophthalmie, une tuméfaction dans l'ombre, des signes inflammatoires autour de globe oculaire, des accoutillages de loin de près avec correction, des signes endocriniens, rhénorégiques.

Tous ces éléments cliniques peuvent orienter vers une pathologie de l'orbite. Et par la clinique, bien sûr, on demande en cas de suspicion d'une pathologie orbitale, pour la biométrie, c'est-à-dire la mesure de longueur axiale, de longueur oculaire. Un scanner jettent, pour s'il y a, envisage un geste chirurgical, une REM.

Et on compte en fonction de l'une des cliniques par la clinique, par l'orthographie, la pléthorographie. Alors on passe rapidement aux anatomies de paupières. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Vous m'entendez? Oui monsieur.

Alors on passe aux anatomies de paupières. Alors voilà le plan de ce chapitre. Introduction, anatomies descriptives des muscles, des muscles de relevé de la paupière, les annexes palpibros, vascularisation, et on termine par réanimation avant de conclure.

Alors les paupières sont de structure cutanée, donc cutanée, musculo-membraneuse, c'est-à-dire qu'elles contiennent de la peau, des muscles et des membranes, en continuité avec les téguments de la face et recouverts par la face antérieure de l'œil. Alors il faut savoir que les paupières répondent, elles jouent à une triple fonction. C'est très important.

D'abord les paupières permettent la protection du globoculaire, c'est-à-dire qu'elles protègent le globoculaire de toute projection dans le corps étranger, toute projection des produits chimiques, donc le fait de cligner les paupières, elles protègent le globoculaire de toute projection extérieure. Le drainage lacrymal, d'abord il contient des glandes lacrymales principales et accessoires, et par le clignement, il permet de drainer le fil lacrymal ou les larmes au niveau du voile lacrymal de drainage. L'expression mimique, parce que tout atteint de paupières, ça va être tenté sur l'expression mimique du visage.

Il existe deux paupières, la paupière supérieure et inférieure. Vous voyez ici, la paupière supérieure, il y a deux repères anatomiques, il faut le savoir. C'est la paupière supérieure, c'est la paupière inférieure, Donc c'est la sourcille, c'est ce que l'on appelle le pli palpibral supérieur et le pli palpibral inférieur.

Voilà, ce forme d'un trait qui est très bien visible, qui permet de différencier entre les paupières et la région externe de la région quadribrale. Donc ce qu'on appelle le pli quadribrale supérieur, le rebord, le bord libre de la paupière supérieure, le bord libre ici, et le bord libre de la paupière inférieure. Le caroncule et le pli sumilunaire.

Le pli sumilunaire, c'est entre la caroncule et la conjoncture bulbaire. Ici, c'est ce qu'on appelle le pli sumilunaire. Le bulbe, le globe oculaire ou le globe oculaire, le pli pavé à l'inférieur, et le sillon palpébrant génial qui sépare la région palpébrale avec la région jugale.

Et la commissure latérale, la commissure plutôt médiale et la commissure latérale. Donc c'est deux repères. Les limites de la région palpébrale, c'est très difficile, surtout pour la région pour la paupière inférieure, qui se poursuit avec l'étirement de la face sans qu'il y ait une limite bien définie.

Donc classiquement, on distingue la limite de la paupière en haut, c'est le bord inférieur de la sourcille, donc schématiquement c'est la limite supérieure, c'est la limite de la région palpébrale, donc c'est le bord inférieur de la sourcille pour la paupière supérieure. En bas, c'est le sillon, c'est le sillon palpébrant génial, ce qui limite la région palpébrale, ou la paupière inférieure avec la région jugale. Et on donne la commissure palpébrale médiane, qui réunit les deux paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure, et la région nasale, c'est-à-dire la limite entre la région nasale ici, et la commissure médiane qui réunit les deux paupières supérieures et la paupière inférieure.

En dehors, c'est la même chose, c'est la réunion de deux régions palpébrales et temporales, la commissure latérale qui réunit les deux paupières supérieures et inférieures, et qui sépare la région palpébrale avec la région temporale. La face antérieure de chaque paupière présente un repli cutanique parallèle au bord libre, c'est le sillon orbitopalpébral, donc la partie située entre le bord libre de la paupière et le sillon orbitopalpébral, la portion taxa, et au-delà du sillon, la portion orbitaire, c'est-à-dire entre le sillon et le bord inférieur de ce sillon ici, c'est le pli pour le sillon

orbitopalpébral qui sépare deux régions, entre le sillon et le bord libre, c'est la portion taxa, entre le sillon et le bord inférieur de ce sillon, c'est la portion orbitaire, qui est recouverte par une pomme mince, et derrière, il y a la graisse orbitale. Ce sillon permet de séparer la région palpébrale en deux parties, en deux portions, la portion orbitaire et la portion taxale, qui répond aux taxes.

La face postérieure est recouverte par la conjonctive palpébrale. Si on fait tourner la paupière supérieure, on trouve une conjonctive palpébrale qui est rosée et lisse. Sa concavité se moule à la face antérieure du globoculaire.

Le bord libre, c'est le bord libre de la paupière inférieure. Sa longueur est de 30 mm et son épaisseur est de 2 à 3 mm. Elle présente deux portions.

Voilà ce bord libre. Elle présente deux portions. Une portion lacrymale ici, c'est-à-dire, en dedans de la portion lacrymale, elle est dépourvue du sile.

Il n'y a pas de sile ici. On appelle la portion lacrymale. Elle représente environ 1,5 de la totalité de la longueur du bord libre.

Et pour la portion ciliaire, c'est le reste du bord libre qui est dépourvue du sile. On représente environ les 4 à 5 de la longueur du bord libre. L'angle externe, il est formé par la réunion de deux paupières, supérieure et inférieure.

Il est situé à environ 6 à 8 mm de robot orbitaire. Et l'angle interne ici, c'est la formation ou la réunion de deux paupières, supérieure et inférieure. La portion se réunit ici pour former l'angle interne.

Elle contient deux formations, comme vous le savez. Donc, c'est la caroncule en avant, la caroncule, et le repli semilunaire en dessous. Alors, pour le tars, c'est quoi le tars? C'est une charge penta fibreuse des paupières.

Elles ont une formation très rigide. Donc, le tars supérieur, ici le tars supérieur, recouvre la paupière supérieure de l'angle depuis le robot orbitaire, depuis le bord libre des paupières, jusqu'à le lit semilunaire. Voilà le pli, plutôt le sillon.

Donc, c'est le tars. Et vous voyez ici que le tars supérieur est plus large, est plus développé par rapport au tars inférieur. Donc, il a une forme ovale.

Par contre, le tars inférieur est moins développé que le tars supérieur. Les deux tars se réunissent pour former ce qu'on appelle l'élément palpebreau. L'élément palpebreau interne et l'élément palpebreau externe.

Lorsque vous entendez parler de l'élément palpebreau interne, c'est la réunion de deux tars, par supérieur et inférieur. Sur une coupe sagittale, vous voyez ici le tars, qui est en pleine

épaisseur à l'intérieur de la paupière, le tars supérieur. Ici, c'est la partie orbitaire de la paupière.

Et ici, c'est la partie palpebrale ou tarsale, parce que la paupière répond en arrière au tars. Alors, quels sont les muscles de la paupière? D'abord, le muscle relèveur de la paupière supérieure, qui permet l'ouverture palpebrale. Elle est éternée par le nerf motoroculaire commun.

Il faut retenir que la paupière est éternée par le nerf motoroculaire commun. Ce muscle relèveur prend origine au niveau de l'enfoncement de l'orbite avec les autres régions du muscle droit et se porte en avant entre le droit supérieur et la paroi supérieure de l'orbite. Le muscle relèveur se termine par un tendon terminal ou un fission aponeurotique né de corps musculaire.

On regarde l'équateur globoculaire. Il forme un éventail sous monosore globoculaire. La base de cette terminaison répond à tout à la largeur de la paupière supérieure.

Les insertions de l'aponeurotique muscle relèveur de la paupière sont triples. D'abord, il a une terminaison cutanée responsable de plaies palpebrales supérieures. Cette plaie palpebrale est la terminaison de la portion cutanée du muscle relèveur de la paupière.

Pour les éléments tarsales, il se termine pour la moitié inférieure de la face externe de la tarse et pour les ailerons externes et internes, c'est pour les insertions osseuses. D'abord, il y a le muscle du moulin. C'est un muscle très réduit.

C'est un muscle de petite taille qui est né plutôt à la face inférieure du muscle relèveur et se termine sur le bord supérieur de la tarse. Vous voyez ici l'origine du muscle relèveur de la paupière supérieure au niveau de l'apex orbitaire. Au niveau de l'apex orbitaire, plutôt au-dessus, il y a le canal optique, le muscle relèveur de la paupière, l'ornique supérieure et le muscle droit supérieur.

Donc, c'est l'origine au niveau de l'endosyne, de l'apex orbitaire. Au-dessus, on a donc l'anneau d'honneur optique entre le droit supérieur et le muscle oblique supérieur. Vous voyez ici, il loge la paroi supérieure de l'orbite entre le droit supérieur et la paroi supérieure d'orbite.

Il se termine par des terminaisons tendue-noeuds au niveau de la tarse. Il y a une partie qui traverse le tissu cutané au niveau de la peau. Donc, une terminaison cutanée, une terminaison tarsale et une terminaison latérale au niveau orbitaire.

Vous voyez ici, le muscle relèveur de la paupière, comment il se réfléchit et se moule sur la cavité orbitaire. Donc, après avoir pris naissance au niveau de l'apex orbitaire, il se dirige en éventail entre le droit supérieur et la paroi supérieure d'orbite. Il se réfléchit au niveau de la paupière pour donner, en faisant tendue-noeuds, trois types cutanés qui traversent la peau.

Deuxièmement, après avoir terminé le travail sur la tarse et sur la paroi orbitaire. Vous voyez ici sur l'image, le muscle relèveur de la paupière, comment l'insertion sur le muscle relèveur de la paupière. L'insertion, la terminaison des fibres tendue-noeuds au palaisier, le rôle de relèveur sur

la tarse et d'autres éléments qui traversent la peau, qui se termine à la face postérieure de la peau.

L'orbiculaire, c'est un autre muscle qui est contenu dans l'orbite de la paupière. C'est un muscle plat, circulaire, formé de plusieurs fissons, deux portions partout dans l'orbitaire, énérvé par le nerf facial. Pour retenir ça, l'orbiculaire est énérvé par le nerf facial.

Il joue un rôle au niveau de l'inclusion palpibrale. On distingue deux parties, la partie orbitaire qui recouvre tout le poteau au-dessous de la base de l'orbite, et l'orbiculaire qui se divise en trois fissons, la portion marginale et la portion pré-tarsale, la portion pré-surface. Vous voyez ici deux portions, la portion orbitaire, c'est-à-dire entre le sillon palpibrale et le sourcil, ce qu'on appelle l'orbiculaire orbitaire.

L'orbiculaire palpibrale, c'est circulaire, qui contient trois portions, la portion marginale, la portion pré-tarsale, en avant de tarse, et la portion pré-septale, au niveau du septum. Pour d'autres éléments anatomiques des paupières, c'est le septum orbitaire et la charpe non-fibreuse. D'abord, le septum orbitaire, c'est une forme d'une lame, d'une membrane fibreuse, très mince, blanc, qui relie le robot orbitaire au bord supérieur de tarse.

Voilà le tarse, ici, et le robot orbitaire ici. Cette partie, cette membrane fibreuse qui relie le robot orbitaire au tarse, s'appelle le septum orbitaire. C'est-à-dire que le septum maintient, relie le tarse au robot orbitaire.

Il est plus résistant au périphérique qu'au centre, et délimite la loge orbitaire, et livre passage aux éléments vasculieux nerveux, et assure la contention de la graisse orbitaire. Le tarse, c'est quoi le tarse ? Un tissu conjonctif tensifié et fibreux élastique, arrimé au tendon et au septum, où il forme l'armature de la poupière, et les dimensions sont égales entre le tarse supérieur et inférieur. Ici, le tarse supérieur est plus développé que le tarse inférieur.

Ici, c'est le septum, le tarse inférieur, et le tarse supérieur. Ici, c'est le muscle releveur de la poupière supérieure, qui donne des ailerons qui s'insèrent sur le tarse supérieur. Ici, vous voyez, c'est le tarse.

Vous regardez ici, c'est le muscle releveur de la poupière. Le muscle du muller, c'est une petite muscle qui s'insère sur la face inférieure du muscle releveur. La terminaison du muscle releveur par des terminaisons tarsales, ici des tarsales, et des terminaisons cutanées.

Des terminaisons cutanées, ce qui est bleu, ce qui est vert, ici, c'est les terminaisons cutanées du muscle releveur de la poupière supérieure. Les annexes patibrales sont formés par des glandes suivantes, des glandes mébimus, qui sont contenues à l'intérieur du tarse, qui permettent la sécrétion lépidique du fim lacrima, ou la couche lépidique du fim lacrima. Les glandes de muller sont annexées aux cils, qui permettent la sécrétion foudrée par le fim lacrima.

Et les glandes osées sont donc annexées aux cils et aux poils de la paupière sébastée. Toutes ces glandes assurent la sécrétion de base lacrymal. Pour la vascularisation de la paupière, elle est assurée par les artères palpebrales, donc les branches de l'artère ophtalmique.

Il existe deux branches, palpebral supérieur et inférieur. On a déjà vu ça. Les artères palpebrales supérieures, supérieures, médiales, et médiales supérieures et inférieures, qui donnent marginal et périphérique.

Pour la vascularisation des veines, au niveau des paupières, les veines sont drainées vers la veine angulaire. Et au niveau des paupières inférieures, les veines sont drainées par les veines faciales. Pour l'application clinique, s'il y a un ptosis, une chute de la paupière supérieure, qu'on appelle un ptosis.

Ici, c'est un abcès, un abcès au niveau de la paupière. Donc, c'est une infection aiguë des paupières, qu'on appelle un chalazion. C'est comme ça.

C'est effectué. C'est un enregistrement infecté au niveau de TAF. Ici, une plaie des paupières, une plaie en pleine épaisseur.

C'est la même chose ici avec des insertions de la paupière. C'est un entropion. En retournement, la paupière en dedans avec des cils, qui trottent sur la cornée et sur la conjonctive.

Un corps étranger sur la conjonctive palpébrale. Et d'autres éléments, entropions et extropions. On passe rapidement au tumeur des paupières.

Pour conclure, les paupières forment, de chaque côté, des structures cotidiennes musculaires. Elles ont un rôle pour la protection du globe oculaire, pour la sécrétion, pour l'étalement du film lacrymal sur la cornée. Il est richement vascularisé et innervé.

Il est classique de distinguer, sur le plan géologique, deux portions. La portion verticale, qui a pour sucs, contient deux portions tarsales et sépales. Et deux portions, dont le sens antérieur et postérieur, pour la lamelle postérieure.

C'est la lamelle antérieure et la lamelle postérieure. On passe rapidement au système lacrymal. Le système lacrymal, on n'a pas beaucoup de temps.

Il reste presque une demi-heure. C'est bon ? Vous m'entendez ? Oui, monsieur. Très bien.

Alors, si vous avez des questions, pour l'anatomie du système lacrymal, rapidement, c'est quoi le système lacrymal ? C'est constitué par plusieurs éléments qui permettent la formation des larmes, leur répartition sur la surface antérieure du globe oculaire et leur évacuation. Il comporte deux éléments. L'appareil qui sécrète les larmes, appelé l'appareil lacrymal sécréteur.

Essentiellement, le clone lacrymal principal est l'accessoire. Et l'appareil lacrymal extraiteur, la

voie de drainage, qui élimine les larmes. Qui sécrète et qui élimine.

Le film lacrymal, c'est quoi le film lacrymal ? C'est un liquide qui participe à la nutrition, le lavage et la protection de la surface antérieure du globe oculaire. Donc, sa qualité et sa bonne répartition. La qualité, c'est-à-dire qui contient tous les éléments nutritifs.

Et sa bonne répartition, qui doit être uniforme sur la cornée, implique une sécrétion qui est diversifiée, qualifiée et une expression adaptée. Donc, le film lacrymal contient trois couches. D'abord, c'est ça, une coupe antérieure-postérieure, c'est la cornée.

Voilà, vous regardez ici la cornée. L'épithélium cornéenne. Ici, la couche mycoïde, qui est en contact direct avec la cornée.

La couche mycoïde, qui est en contact direct avec la cornée. Et une grande couche, qu'on appelle la phase aqueuse, qui contient de l'eau. Presque 90% du film lacrymal contient de l'eau.

C'est la couche intermédiaire. Et une couche superficielle, ici, c'est la couche lipidique, qui est en contact direct avec l'air. Donc, ici, c'est l'air.

La couche superficielle, c'est la couche lipidique. Intermédiaire, la couche aqueuse. Mycoïde, la couche mycoïde, c'est entre, c'est-à-dire, qui adhère à l'épithélium cornéenne.

C'est la même chose ici. C'est l'oeil, c'est le globoculaire, c'est la cornée. C'est la couche, ici, c'est la couche lipidique.

La couche aqueuse. Et la couche mycineuse, qui est en contact direct avec la cornée. L'appareil lacrymal, donc l'appareil lacrymal sécréteur, le gland lacrymal principal et accessoire, et l'appareil excréteur, le poids lacrymal de drainage ou le poids lacrymal d'évacuation.

Il contient ces éléments, le lac lacrymal, les points lacrymaux, les canaux lacrymaux, le canal d'une eau, le canal lacrymal nasal, le point d'eau lacrymal nasal. Rapidement, on passe que la glande lacrymale, deux types de glandes lacrymales accessoires. D'abord, ici, située au niveau de la paroi supérieure de l'orbite, blanc support externe.

La paroi supérieure de l'orbite, c'est la force lacrymale où se loge la glande lacrymale principale. Vous voyez ici la glande lacrymale principale, la paroi supérieure externe de l'orbite. Ici, vous voyez la glande lacrymale de l'aube, l'aube supérieure, plutôt, de l'aube supérieure interne et inférieure.

Elle est séparée par les ailerons du muscle relevant de la paupière. Ici, c'est la glande lacrymale principale. La même chose.

Elle est séparée en deux portions par le muscle relevant de la paupière, une partie papillurale antérieure et inférieure, et une partie orbitale supérieure, ici supérieure et postérieure. Supérieure

et postérieure. La partie inférieure orbitale, elle est antérieure et inférieure et la partie orbitale est postérieure et supérieure.

De l'aube, la morphologie, c'est le jaune rougeâtre de forme bilobée. Il mesure environ 20 mm de long, 15 mm de large, 3 à 5 mm. De l'aube, la partie postérieure est orbitale et la partie papillulaire est inférieure.

Vous voyez ici ce qu'on appelle des canalicules lacrymaux. C'est un petit piretuit qui s'ouvre au niveau de sa conjonctive supérieure lorsqu'il y a une sécrétion au niveau de l'arme et se draine par ce qu'on appelle des ductus lacrymaux qui se déversent au niveau de sa conjonctive supérieure et inférieure. La glande lacrymale principale et qui sont séparées par les ailerons sur le bord de la poubelle supérieure.

C'est la même chose. Il occupe la fosse lacrymale de l'os frontal. Il faut retenir ça.

C'est une question qui peut parfois... On se demande quels sont les rapports de la glande lacrymale au niveau de la fosse lacrymale de l'os frontal. Ces rapports se font avec le septum orbitaire, en arrière la graisse orbitaire, le cul de sa conjonctive inférieure et en dedans par le bord extérieur de droite supérieure et en dehors par le bord supérieur de droite extérieure. Les deux parties de la glande lacrymale sont entourées par un tissu conjonctif fibreux qui est relié au périoste.

Vous voyez ici dans la glande lacrymale, c'est le muscle droit extérieur et la droite supérieure. Les rapports de la glande lacrymale principale se font en bas au niveau du cul de sa conjonctive, en arrière avec le bord supérieur de droite extérieure et en arrière avec le muscle droit supérieur. Vous voyez ici, c'est des canalicules, des nectules lacrymaux qui déversent la sécrétion lacrymale principale au niveau du cul de sa supérieure et du cul de sa inférieure.

Les glandes lacrymales accessoires sont devenues lacrymales disséminées, situées, localisées au niveau de la conjonctive et des tarses. Ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base. Il s'agit de glandes de Crous et de Woffering, des glandes de Mebimus, des glandes de Zès et de Moll.

Ici, vous voyez la glande lacrymale principale, la glande de Woffering au niveau du cul de sa conjonctive, et la glande de Crous au niveau de la conjonctive palvébrale. Ici, la conjonctive palvébrale. Ici, ce qu'on appelle les crêtes ou les cellules amiqueuses au niveau de la conjonctive bulbaire.

Ici, la glande de Mebimus à l'intérieur de la glande de tarses. Et ici, c'est la glande de Zès et la glande de Moll. C'est ce qu'on appelle les glandes lacrymales accessoires et qui permet la sécrétion, qui assurent la sécrétion de base de films lacrymaux.

Il y a la sécrétion de base qui est assurée par les glandes lacrymales accessoires. Il y a la

sécrétion réflexe qui est assurée par la sécrétion de glandes lacrymales principales. Donc, la glande lacrymale principale assure la sécrétion de base et la sécrétion réflexe.

Par contre, la sécrétion de base est assurée par la sécrétion des glandes lacrymales accessoires. Vous voyez ici le lac lacrymal, le mynisque de l'arbre qui est coloré par un colorant fleurissine. rapidement, c'est le film lacrymal, la rivière lacrymal, ici, on appelle le lac lacrymal.

Pour l'anatomie de voies excrétrices, le lac lacrymal est point lacrymo, le canal lacrymo, le canal d'union, le canal sac lacrymo et le conduit lacrymo nasal. On appelle les voies de drainage ou les éléments anatomiques qui entrent dans la construction de voies lacrymales excrétrices. Ici, le sac lacrymal est un espace qui permet la collection des larmes qui se drainent au niveau du bord libre la rivière lacrymal.

Cet espace est formé par deux paupières qui contiennent la carotyle et le repli somulaire. Ici, c'est le lac lacrymal, c'est l'espace qui contient le lac lacrymal. Les points lacrymals sont situés sur le bord libre à l'union de la portion ciliaire et la portion lacrymal.

Ici, vous voyez c'est le mya qu'on appelle le mya au point lacrymal. Mya lacrymal inférieur et le mya lacrymal supérieur. Ici, déjà un mya lacrymal et ici déjà un sondage du mya lacrymal inférieur et supérieur.

C'est ce qui est situé sur le bord libre entre la portion lacrymal et la portion ciliaire du bord libre. Les canalicules lacrymaux sont les canalicules supérieures et inférieures qui font deux portions horizontales et verticales. Les canalicules supérieures et les canalicules inférieures.

Les canalicules supérieures ici et les canalicules inférieures. Ils contiennent deux portions, une portion verticale très courte, ici c'est une portion ascendante et une portion verticale descendante et une portion horizontale et une portion horizontale. On appelle les canalicules supérieures et les canalicules inférieures deux portions.

La portion verticale est très courte pour les deux canalicules supérieures et inférieures et une portion horizontale est plus longue. Les deux portions, le canal d'union s'est formé par la réunion des deux poules pour les canalicules supérieures et inférieures pour s'aboutir au niveau du sac lacrymal. Voici le canal d'union.

Ici, le canal d'union c'est la canalicule supérieure et la canalicule inférieure qui se réunissent pour former le canal d'union qui se bouge au niveau du sac lacrymal. Le sac lacrymal c'est le collecteur des larmes. Sa capacité de base est de 30 à 20 mm cube.

C'est un réservoir cylindrique aplati de 12 à 14 mm de roue, de 3 à 8 mm de diamètre. Voilà le sac lacrymal. Le canal d'union, le sac lacrymal et le canal lacrymonasal.

On passe rapidement. Le sac lacrymal, les canalicules supérieures et inférieures, le canal d'union s'est formé pour s'aboutir au niveau du canal lacrymonasal. Le canal plutôt du sac lacrymal c'est

le sac lacrymal du canal d'union supérieur et c'est ce canal lacrymonasal qui s'ouvre au niveau du milieu inférieur.

Le canal lacrymonasal s'est situé dans le canal de ce creuset dans le maxillaire supérieur contre le sinus maxillaire qui est le niveau de la hauteur de l'esprit d'un congélateur. C'est donc le niveau de la hauteur de l'esprit d'un congélateur. Les canaux d'union sont enfaînés, par ce canal lacrymal.

Le sac lacrymal, il est formé par un canal lacrymonasal qui découvre le négocié donc c'est le canal lacrymonasal qui est en bas en bas sur la barre du sac lacrymal Il faut retenir que les voies de drainage ou les voies d'évacuation du lac Lacrimal peuvent être séparées en deux parties. La partie horizontale, ici c'est la partie horizontale, et la partie verticale. La partie horizontale contient le lac Lacrimal, le lac Lacrimal, le lac Lacrimal et le lac Lacrimal.

Les canaux lacrimaux, lac Lacrimal inférieur et supérieur, le canal d'union, puis la portion verticale des voies Lacrimal de drainage, elle contient le sac Lacrimal et le canal Lacrimal-Nasal. Donc deux portions. Si on peut séparer les voies de drainage de la circulation Lacrimal, deux portions, la portion horizontale, ce qui est horizontal, et la portion verticale.

La portion horizontale, c'est-à-dire le lac Lacrimal, les points Lacrimaux, le canal lacrimal supérieur inférieur, le canal Lacrimal d'union, et la portion verticale des voies Lacrimal de drainage, c'est le sac Lacrimal et le canal Lacrimal-Nasal. Vous voyez ici les poutres supérieures et inférieures, les canaux lacrimaux inférieurs, les canaux lacrimaux inférieurs, les canaux lacrimaux supérieurs, les canaux lacrimaux d'union, le sac Lacrimal-Nasal et le canal Lacrimal-Nasal. Et si vous regardez sur ce qu'on fait, c'est les orifices du canal lacrymonasal.

C'est l'orbite gauche, l'orbite droite et c'est sur l'orifice supérieur dans l'orbite droite, par exemple, ici. Alors, si on passe rapidement à la physiologie, la vascularisation. Donc, il est vascularisé et assuré par l'artère lacrymal qui est au gange collatéral de l'artère ophtalmique et de l'artère méningée.

Donc, c'est l'artère ici, c'est la glande lacrymale principale, assurée par l'artère lacrymale et éternuée par la mer lacrymale. Donc, la vascularisation veineuse est entraînée par la mer lacrymale. Puis, la vascularisation lymphatique est collectée dans les congléons parotidiens profonds, juxtagulaire ou le congléon pré-tragéen.

Donc, on passe rapidement pour les voies lacrymales. Pour les voies lacrymales, la vascularisation est assurée par les artères nasales, l'artère nasale, l'artère par le bras supérieur-intérieur et les artères onguinaires. L'innervation, donc, pour la glande lacrymale principale, pour la glande lacrymale.

Donc, l'innervation est assurée par le nerf lacrymale sécrétoire, c'est-à-dire la sécrétion par la sympathie par le noyau de la tête. Et pour l'innervation sécrétoire sympathique, il est assuré par

la moitié du cervical. Donc, on passe rapidement.

L'application ici est une tachylosis aiguë, c'est une infection, une surenfection, une supériorité de la glande lacrymale, plutôt de sac lacrymal, et qui s'est fait utiliser avec une tuméfaction au niveau de l'ongle, rougeur, sécrétion, douleur. Donc, ici, si on fait un sondage, par exemple, on passe une sonde, on appelle ça une sonde de borne, au niveau de la glande lacrymale. Puis, on traverse le canal aiguë inférieur jusqu'au niveau du canal de l'union, on passe le canal de sac lacrymal jusqu'au niveau de l'hôpital.

Et s'il y a un passage, on vérifie s'il y a un reflux, s'il y a une obstruction, pour savoir s'il y a un reflux, plutôt une obstruction au niveau du drainage des fois de la glande lacrymale. Ici, voilà un sondage, par un sondage, c'est la même chose, le canal aiguë supérieur. Ici, lorsqu'il y a une obstruction du canal lacrymal nasal, il y a une obstruction, on fait une pression au niveau de l'ongle interne, au niveau, on regarde le sac, il y a un reflux, un reflux de sécrétion.

Donc, ça témoigne qu'il n'y a pas de passage au niveau du canal lacrymal nasal. J'ai un prolapsus de la glande lacrymale principale, et sur un numéraire de points lacrymaux, au lieu d'un point, il y a deux points, c'est une malformation congénitale. Ici, il y a une section du canal aiguë, et le canal aiguë, c'est l'inflammation du canal aiguë.

Alors, on passe rapidement. Pour conclure, l'appareil lacrymal comporte deux parties physiologiques et anatomiques très différentes. Il y a un système de sécrétion de l'arbre reçu par la glande lacrymale et un système d'évacuation de la glande lacrymale.

Alors, il nous reste 20 minutes, on passe rapidement pour l'anatomie du muscle oculomoteur. C'est bien, c'est bon. Il faut savoir qu'il y a six muscles oculomoteurs qui permettent la mobilisation du bulbe de l'œil dans les différentes directions de regard.

Donc, quatre muscles droits et deux muscles obliques. Ils sont innervés par trois paires crâniennes, pour le nerf motocollant commun, donc il innerve le muscle droit interne, le muscle droit supérieur, le muscle droit inférieur, le petit oblique ou l'oblique inférieur, et pour le muscle oblique supérieur, il est innervé par le nerf pathétique ou le nerf trochilaire, pour le droit externe, il est innervé par le nerf motorexterne. Sur le plan anatomique, descriptif et topographique du muscle, le muscle droit prend l'origine au niveau tontodosine, par une origine commune, ce dernier s'insère sur le tubercule au pied et se divise en quatre languettes, une languette supéro-interne, une languette inféro-interne, supéro-externe et inféro-externe, alors ces deux languettes sont réunies et se forment entre deux et sont réunies pour former l'origine de chaque muscle droit motocollant.

Vous voyez ici l'origine du muscle droit, ici c'est le muscle droit supérieur, ici c'est l'anodosine, qui divise la fissure orbitaire en deux portions, en dehors de l'anodosine Le nerf, le muscle droit supérieur, le muscle droit latéral, ici le muscle oblique supérieur et le muscle droit releveur, donc

le releveur, le paupière supérieur, le muscle droit supérieur, le muscle droit latéral, ici c'est le muscle droit inférieur et ici le muscle droit latéral. Vous voyez ici que chaque muscle est formé par deux languettes, une languette inférieure, deux languettes, deux languettes, une languette, l'autre, une languette, l'autre et chaque muscle est formé par deux, qui sont réunies entre deux pour former l'origine de chaque muscle. C'est la même chose ici au niveau de l'orbite, de l'orbite orbitaire qui montre l'insertion du muscle sur le moteur, c'est la fissure orbitaire, l'anodosine, le trou optique, l'artère ophtalmique, le nerf optique et sur le muscle droit supérieur, le muscle droit latéral, parce que c'est l'orbite droite, le muscle droit médial, le muscle droit inférieur, ici les petites réductions et qui forment, ici c'est ce qu'on appelle l'espace intracognite, lorsqu'il y a les insertions de chaque muscle connaissances au niveau de l'orbite orbitaire, l'anodosine, ils se convergent en avant et ici c'est l'espace intracognite, c'est-à-dire à l'intérieur du muscle.

Vous voyez ici, c'est la même chose, le canal optique, le trou, avec tous les nerfs qui sortent au niveau, qui sortent par la fissure orbitaire, la branche supérieure de 3, la branche inférieure de 3 et le nerf 6, ici le nerf pathétique, le nerf lacrymal, le nerf frontal. Vous voyez ici, c'est la même chose, donc le muscle droit supérieur, le muscle droit inférieur, le muscle droit latéral et le muscle droit immédiat. Alors pour les 4 muscles droits, ils se portent en avant, dirigeant légèrement en avantaille pour gagner la partie antérieure du globe oculaire, qu'ils en servent de leur compte en terminaux.

Donc ils forment un compte musculaire, assommé postérieurs, formé par les membranes intermusculaires. Vous voyez ici l'insertion, l'origine du muscle oculomoteur, qui se dirige en avant, en avantaille et qui forme un compte musculaire à l'intérieur qu'on appelle le muscle antraconique, l'espace plutôt, l'espace antraconique et l'espace extraconique et qui se termine au niveau de la sclère dans la région préopératoire. Alors, voilà l'espace antraconique à l'intérieur du compte musculaire et l'espace extraconique, c'est-à-dire l'espace entre les muscles et le robot orbitant, l'espace antraconique.

Alors chaque muscle se transforme en un tendon large de 10 mm environ, long de 5 à 10 mm de couleur blanc-nacré. Tous les muscles droits se terminent au niveau de la sclère, le droit interne à 5,5 mm du limbe, le droit inférieur à 6,5 mm, le droit extérieur à 7,7 mm et le droit supérieur à 7,7 mm du limbe. Alors leur terminaison sur ce schéma montre la terminaison du muscle oculomoteur droit sur la sclère, le limbe.

Ici sur le limbe, c'est-à-dire que l'espace entre la cornée transparente et la sclère opaque, l'insertion de chaque muscle en arrière du limbe, ici sur le limbe, le limbe, le limbe, donc c'est l'insertion de muscles en arrière du limbe, d'accord. Ici le droit latéral, il s'insère en arrière du limbe de 5,5 mm, pour le droit inférieur, 6,5 mm du limbe, et pour le droit latéral, c'est 7,7 mm du limbe, pour le droit supérieur, c'est 7,7 mm du limbe. Voilà sur l'orbite droite, l'insertion du muscle droit latéral, du muscle droit médial inférieur et du droit supérieur.

Sur ce schéma, le tendon du muscle droit, alors ici c'est le muscle droit latéral, ici c'est le globe

oculaire qui est dévié, c'est ici le limbe, et l'insertion, vous regardez ici l'insertion du muscle droit latéral, environ de 7 mm du limbe, l'insertion du muscle droit latéral, environ de 7 mm du limbe. Ici, c'est l'insertion du muscle droit médial, ici vous regardez l'insertion du muscle droit, par rapport au limbe, c'est 5,5. 5,5, vous regardez cet espace entre l'insertion du droit médial par rapport au limbe, et ici par rapport au limbe, ici le droit médial et le droit latéral.

Alors pour l'oblique supérieur, alors les muscles obliques, donc après avoir vu le muscle droit, donc supérieur, droit inférieur, latéral et médial, les muscles obliques, il y a deux types, il y a deux muscles obliques, il y a l'oblique supérieur et l'oblique inférieur. Pour l'oblique supérieur, sur le muscle le plus long du muscle oculomoteur, il s'agit du muscle dégastrique, un muscle qui possède deux masses, les fibres sont reliées par un tendon, l'origine au niveau de fond de l'orbite, au niveau du tendon de zygme, un peu au-dessus et en dedans de trois rotules, en dedans de l'insertion de la populaire supérieure, et son origine est située entre l'origine du droit supérieur et le droit médial. Vous regardez ici, c'est l'origine du droit du muscle oblique supérieur, entre l'origine du muscle de la populaire et le muscle de droit externe.

Donc après avoir pris son origine au niveau, il longe la paroi supérieure du support interne de l'orbite, jusqu'au niveau de la forcette trochléaire, au niveau de la paroi supérieure de l'orbite. Ici c'est la forcette trochléaire. Le trajet comporte deux parties, une partie directe de son origine à la trochlée et une partie réfléchie.

Donc deux parties, une partie directe depuis son origine, depuis l'apex orbitaire jusqu'au niveau de la trochlée, et une partie réfléchie tendineuse de la trochlée au niveau populaire. Voilà une partie directe, ou une partie horizontale, c'est la même chose, une partie directe ou une partie horizontale depuis son origine au niveau de la tendose, jusqu'au niveau de la poule et de la grande trochlée, et une partie réfléchie ou une partie verticale, tendineuse. Une partie réfléchie ou une partie verticale, c'est la même chose.

Elle est tendineuse, donc c'est pour cela que le muscle oblique supérieur est appelé digastrique parce qu'il comporte deux courbes musculaires. Il y a une première insertion ici et une deuxième insertion ici. Alors il passe au-dessous du droit supérieur, donc après avoir traversé l'orbite, le support interne de l'orbite, puis son rôle sur le globe oculaire et s'il panouit, on est volontaire pour s'insérer à la partie support externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire.

Regardez ici le muscle oblique supérieur, le muscle droit supérieur. Donc après avoir fait la réflexion au niveau du robot orbitaire, de la force électrocléaire, la partie réfléchie passe au-dessous du muscle droit supérieur pour s'épanouir et s'insérer sur la partie de l'hémisphère postérieur du globe oculaire, la partie support externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire. Ici c'est la même chose, il passe au-dessus du muscle droit supérieur pour s'insérer dans la partie support externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire, c'est-à-dire l'hémisphère postérieur, c'est l'hémisphère antérieur.

Entre l'insertion, les insertions musculaires, tout ce qu'il y a en avant des insertions musculaires, c'est l'hémisphère antérieur. Et tout ce qui est postérieur, qu'on appelle l'hémisphère postérieur ou rétroéquatorial. C'est pour cela que la terminaison du muscle oblique supérieur, c'est ce qu'on appelle les insertions prééquatorielles ou rétroéquatorielles, pour l'hémisphère postérieur du globe oculaire, c'est-à-dire en arrière, les insertions du muscle droit.

Pour l'oblique inférieur, c'est le plus court du muscle oculomoteur, le seul qui ne prend pas son origine au niveau de l'orbite, au niveau du sommet orbitaire. Il est né par des côtes fibreuses, des fibres tendineuses de planchers de l'orbite, à sa partie antérieur interne, en dehors de l'orbite du canal lacrymonasal. L'origine de l'oblique inférieur est plus basse par rapport à son insertion, ou bien à son terminaison.

Vous regardez ici que l'insertion du muscle oblique au niveau de la planche de l'orbite, de sa partie antérieure interne, en dehors du canal lacrymonasal, son insertion est plus basse par rapport à sa terminaison. Ici, c'est l'insertion au niveau plutôt de son origine et son insertion. Contrairement au muscle oblique supérieur, il se termine dans la partie support externe, en arrière du muscle droit inférieur.

Il passe sur le droit inférieur, puis il s'enroule sur le globe oculaire, à son attache, et se termine dans le cadre inférieur-extérieur. Contrairement au muscle oblique supérieur, dans le cadre support extérieur. Le muscle postérieur du globe oculaire, sur le droit supérieur, sur le droit latéral.

Vous regardez ici, c'est un muscle antagoniste par rapport au muscle oblique supérieur, parce que le fait de se terminer au niveau du cadre inférieur-extérieur du muscle postérieur du globe oculaire, alors que le muscle oblique supérieur se termine au niveau du cadre support extérieur du muscle postérieur du globe oculaire, donc c'est un muscle antagoniste par rapport à l'oblique supérieur. On voit constamment du muscle droit supérieur issu du muscle oblique inférieur. Il faut retenir quelques points très importants.

On s'est compensé pour le muscle droit, donc un muscle par chaque paroi orbitale. Pour le droit, on parle du muscle droit, donc un par chaque paroi. Médian pour la paroi médiane, supérieur pour la paroi supérieure, latéral pour la paroi latérale et inférieur pour le plancheau de l'orbite.

Chaque muscle entouré par d'un fascien propre, avec un fascien intermusculaire entre chaque muscle. L'ensemble est constitué d'un cône musculaire à son milieu postérieur au niveau de l'apex et à sa base antérieure au niveau du globe oculaire. C'est ce qu'on appelle le cône fasciculomusculaire.

Les animaux qui traversent, qui pénètrent dans l'orbite en passant par l'anneau du zyde sont anthraconiques. Automatiquement, ils sont anthraconiques parce qu'ils traversent la fissure orbitaire au niveau de l'anneau du zyde. Ils sont automatiquement à l'intérieur de l'insertion du

muscle oculomoteur.

Les branches de droit, les branches supérieures à travers le muscle de l'anneau de droit, le nerf cis, le nerf nasociliaire, la racine sympathique du bronx musculaire et la vienne ophtalmique médiale. Pour les animaux qui traversent la fissure orbitaire supérieure sans passer dans l'anneau du zyde, ils sont extraconiques. Le nerf frontal, le nerf lacrimonasociliaire et le nerf tranquillaire et la vienne ophtalmique supérieure.

Pour les faciales, la gaine musculaire, chaque muscle oculomoteur est entouré par une gaine. Chaque muscle est entouré par une gaine. Les muscles et les gaines de chaque muscle sont reliés entre eux par des membranes intermusculaires également très réminiscées, appelées osomusculaires.

Voilà la gaine musculaire. Chaque muscle est entouré par une gaine et entre les gaines, il y a ce qu'on appelle les membranes musculaires ou ce qu'on appelle les gaines intermusculaires. La gaine musculaire et les gaines intermusculaires.

La vascularisation est assurée par les artères musculaires inférieures et constantes. Ce sont les branches collatérales les plus importantes de l'artère ophtalmique. Et également par les artères musculaires latérales, médianes et inférieures supérieures.

Alors on repasse rapidement. La vascularisation veineuse, le muscle oculomoteur est entraîné par les viennes hypersclérotiques. Donc il n'y a pas de grand-chose.

Pour le nerf droit, il assure l'innervation. C'est très important à savoir. C'est une question d'examen.

Le nerf droit assure l'innervation motrice de droits supérieurs, médians, inférieurs et obliques inférieurs. Par contre, le muscle oblique est innervé par le nerf trochléaire. Le nerf cis assure seulement l'innervation motrice de droits latéraux.

Donc il y a trois nerfs qui assurent l'innervation. Pour le nerf droit, la majorité des muscles oculomoteurs sont innervés par le nerf droit, le nerf moteur oculocommun. Par contre, le nerf trochléaire c'est pour l'oblique supérieur ou l'oblique.

Le nerf cis c'est pour les muscles droits latéraux. Alors quelques rappels rapidement, quelques notions physiologiques du muscle oculomoteur. L'action d'un muscle, le muscle oculomoteur, l'action d'un muscle, c'est la position dans laquelle il est.

Il faut orienter le globe oculaire pour rechercher la déficience, la paralysie ou l'hyperaction. Par exemple ici, si on cherche le muscle droit latéral, on fait tourner l'œil à droite, en dehors. Si on cherche par exemple ici pour l'œil gauche, pour le droit, ici c'est pour le droit.

On cherche une paralysie ou une déficience ou une hyperaction d'un muscle droit latéral. Donc

on fait tourner l'œil en dehors, ici, en dedans. Pour le droit supérieur, c'est en haut.

Pour le droit inférieur, c'est en bas. Donc le droit latéral, c'est une abduction, en dehors. Le droit interne, c'est abduction, en dehors.

Abduction, c'est en dedans. Le droit supérieur, il a une triple action quand même. Il a une élévation, il permet une élévation.

Il permet une intorsion, c'est-à-dire qu'il tourne le globe oculaire dans le sens d'une montre. Ici, dans le sens d'une montre. Dans le sens d'une aiguille d'une montre.

Et une abduction, c'est-à-dire une légère abduction, un léger pignon, une légère mobilisation du globe oculaire. Ici, le muscle droit supérieur, il a une triple action. Une action essentielle, primaire.

Une action principale. Une action secondaire. Ce n'est pas une action principale.

C'est une action tertiaire. L'oblique inférieur, c'est la même chose. Élévation, extorsion, abduction, abaissement.

Pour l'oblique supérieur, vous regardez ici que seuls les muscles droit latéral et les muscles médias sont les muscles droit latéral. Oui. C'est quoi l'extorsion ? L'extorsion, c'est le contraire d'intorsion.

C'est-à-dire que dans le sens du globe oculaire, lorsqu'il est mobilisé dans le sens... Le globe oculaire, il a un axe antéropostérieur, un axe X, un axe Y et un axe Z. D'accord ? Lorsque le globe oculaire tourne dans un sens comme ça, dans un axe antéropostérieur. Tu as compris ? Oui, merci. Dans un axe antéropostérieur.

C'est-à-dire un axe qui traverse le globe oculaire depuis en avant jusqu'en arrière. Et lorsqu'on fait tourner le globe oculaire autour de cet axe. C'est-à-dire dans le sens d'une aiguille d'une montre.

Extorsion, c'est le sens contraire, c'est-à-dire le sens contre le sens d'une aiguille d'une montre. C'est-à-dire en dehors vers en dedans pour le droit. D'accord ? En dehors vers en dedans.

Et en dedans vers en dehors. Pour le droit ici, c'est l'exemple ici. Si on fait tourner le globe oculaire comme ça, dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire en dedans vers en dehors, on appelle intorsion.

Et lorsqu'on tourne le globe oculaire de dehors en dedans, contrairement au sens d'une aiguille d'une montre, c'est extorsion. Toujours dans l'axe en dehors postérieur. L'axe Z. Est-ce que c'est compris ? Il ne faut retenir que le droit médian et le droit latéral.

Donc le droit latéral et le droit médian, ils ont une seule action. D'accord ? Par contre, les autres

muscles ont triple action. Alors, le champ d'action, c'est contrairement.

C'est la position d'action au maximum, au-dessus de ce qui est plus caractéristique. Donc, c'est plus encliné. Ici, lorsqu'on est paralysé sous le droit supérieur, on fait regarder le malade en dehors et en haut.

Pour le petit oblique, c'est en haut et en dedans. Pour le droit extérieur, c'est en dehors. Pour le droit latéral et le droit aménien, c'est en dedans.

Pour le droit inférieur, c'est en bas et en dehors. Pour le grand oblique, c'est en bas et en dedans. Alors, ici, il y a 9 positions de regard.

La position primaire. Ici, la position lorsqu'on explore pour le droit gauche, par exemple. Ici, pour le gauche, si on explore le droit supérieur, on fait regarder le malade en haut et en dehors.

Ici, pour explorer également le droit en regard, on regarde le malade en haut et en dehors. Ici, c'est pour le droit inférieur, également pour le droit. Et ici, pour le gauche, c'est le droit inférieur.

C'est un peu physiologique. Vous verrez ça par la suite lorsque vous aurez le cours de la simbiologie. Alors, quelques exemples de paralysie de 4. Ici, une paralysie de 4 droits.

On va regarder ici 6 droits plutôt. On va regarder ici si le malade n'arrive pas à bouger, à dévier son globulaire en dehors, ce qu'on appelle une limitation de l'abduction. On va regarder une hyperaction du muscle droit latéral contre latéral.

On passe rapidement. Pour conclure, on peut dire que le muscle oculomoteur sont deux muscles striés au nombre de 6. 4 muscles droits et 2 muscles obliques situés à l'intérieur du globulaire. Les muscles droits ont une seule action, l'abduction, ou bien l'abduction.

Et pour les muscles droits verticaux, on trouve l'action. Ces muscles sont un élément responsable de l'oculomotrice avec les nerfs crâniens qui les commandent. Je vous remercie.

Est-ce que vous avez des questions? Il reste le chapitre de la conjonctive. Il n'y a pas de grand-chose pour la conjonctive. Il faut retenir la description ou la répartition de la conjonctive bulbaire et la conjonctive palébrale avec sa vascularisation.

Deux éléments anatomiques, deux éléments essentiels. Il faut le reconnaître. C'est la répartition, la conjonctive.

Ce n'est pas la conjonctive bulbaire, c'est la conjonctive palébrale. Et puis la vascularisation de la conjonctive. C'est bon? Oui, monsieur.

Merci beaucoup. Bonne chance. Je vous souhaite un bon Ramadan.

Bonne chance pour les amants. Merci, monsieur. Merci.

Merci à vous.